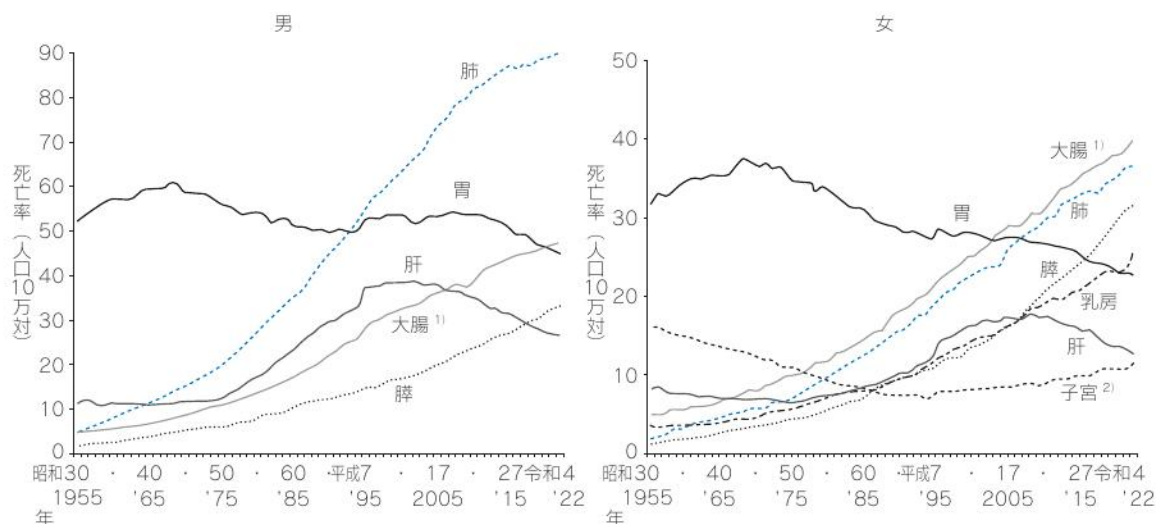




注: 1) 大腸の悪性新生物(腫瘍)は、結腸の悪性新生物(腫瘍)と直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物(腫瘍)を示す。ただし、昭和42年までは直腸肛門部の悪性新生物を含む。
2) 平成6年以前の子宮の悪性新生物(腫瘍)は胎盤を含む。

図2 悪性新生物(腫瘍)の主な部位別死亡率(人口10万対)の年次推移
[厚生労働省: 令和4年人口動態統計月報年計(概数)の概況より引用]

て、日本人の平均寿命を延ばすためにできる努力は何かであろうか。答えは禁煙への啓発活動である。

日本人の非感染性疾患・外傷死亡に対する寄与が大きい「予防可能な危険因子」は、喫煙と血圧(2007年人口動態統計ほか)であるとの報告がある¹¹⁾。喫煙の寄与する死亡は12.9万人(95%信頼区間11.5~15.4万人)で、うち3/4(9.5万人)を男性が占めている。主要な死因は肺癌(4.2万人)、虚血性心疾患(2.7万人)、COPD(1.3万人)であった。平均余命および死亡率に対する各危険因子の影響として、喫煙が最適な状況までコントロールされた場合に、男性の平均余命獲得は、+1.8年(95%信頼区間1.6~1.9年)、女性は+0.6年(0.4~1.0年)であった¹¹⁾。

文 献

- 1) 厚生労働省: 令和2年人口動態統計月報年計(概数)の概況
- 2) 結核研究所疫学情報センター
- 3) 厚生労働省: 入国前結核スクリーニングの実施について
- 4) Namkoong H, et al. Emerg Infect Dis **22**: 1116, 2016. 2014年度厚生労働省厚生労働科学研究委託「非結核性抗酸菌症の疫学・診断・治療に関する研究」
- 5) 政府統計の総合窓口 e-Stat. 人口動態調査/人口動態統計 確定数 死亡 (2021年).
- 6) Izumi K, et al. Ann Am Thorac Soc **16**: 341, 2019.
- 7) 藤田次郎ほか: 沖縄医報 **45**: 1100, 2009
- 8) Nagano H, et al: PLoS One **12**: e0186826, 2017
- 9) GOLD 日本委員会: COPD データ集
- 10) 日本生活習慣病予防協会: COPD の調査・統計
- 11) Ikeda N, et al: PLoS Med **9**: e1001160, 2012